

Проверка гипотезы: существует ли персональный движок «доказательства → доступ» для онкопациента?

Глубокая проверка восьми функций, сформулированных Наумом, по каждой отдельно

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 6 августа 2026 · Метод: проверка каждой из восьми функций отдельным поиском по открытым источникам, затем сведение в матрицу покрытия. Все факты проверены по ссылкам в этот день; непроверенное помечено.

Гипотеза, как она была поставлена

Пациент вводит **диагноз, стадию, биомаркеры и страну проживания** и получает постоянно обновляемый персональный ответ на восемь вопросов:

1. Что действительно нового появилось для моего конкретного заболевания?
2. Насколько сильны доказательства?
3. Применимо ли это именно к моей клинической ситуации?
4. Одобрено ли лечение FDA / EMA / местным регулятором?
5. Доступно ли оно в моей стране?
6. Входит ли оно в государственное или страховое покрытие?
7. Если нет — есть ли клиническое исследование, expanded access или иной легальный путь?
8. И система сама сообщает, когда любой из этих ответов изменился.

Короткий ответ

Нет. Такой системы не существует.

И это не потому, что никто не пробовал. Каждая из восьми функций по отдельности где-то реализована — но **они разложены по разным продуктам, разным аудиториям и разным ценовым категориям**, и ни один игрок не соединяет их в один персональный, непрерывно обновляемый ответ.

Функции 1–3 и 7 закрыты хорошо (в основном США). Функция 4 закрыта частично и почти всегда только по FDA. **Функции 5, 6 и 8 для пациента не закрыты нигде.**

Продукт — это не одна из восьми функций. Продукт — это их соединение.

Матрица покрытия

#	Вопрос	Кто это делает сегодня	Статус
1	Что нового по моему заболеванию	OncoKB, CIViC, My Cancer Genome (базы для врачей); Outcomes4Me; OpenEvidence + NORD; xCures / Cancer Commons	Закрыто — но чаще на уровне <i>заболевания</i> , а не пациента
2	Насколько сильны доказательства	OncoKB Levels 1–4 (Level 1 = биомаркер признан FDA; Level 2 = стандарт помощи по NCCN); ESMO-MCBS/ESCAT; EvidenceAlerts	Закрыто — зрелые общепринятые шкалы
3	Применимо ли к моей ситуации (стадия + биомаркеры)	Leal Health (быв. TrialJectory), Massive Bio, xCures, OncoKB, Navify	Закрыто — но в США и в привязке к подбору исследований
4	Одобрено ли FDA / EMA / местным регулятором	OncoKB — только FDA ; Leal — «FDA-approved»; национальные реестры (напр. реестр лекарств Минздрава Израиля) — отдельно и вручную	Частично — почти всё завязано на FDA; EMA и местные регуляторы разрознены
5	Доступно ли в моей стране	Данные есть, но в B2B-инструментах для фармы: GlobalData POLI, NAVLIN (EVERSANA), RxData, Beacon — 100+ рынков. Плюс ежегодный отчёт EFPIA W.A.I.T.	РАЗРЫВ — пациенту не показывает никто
6	Покрывается ли государством или страховкой	Те же B2B-базы; национальные сайты HTA (NICE, G-BA, SMC...); «корзина здоровья» в Израиле	РАЗРЫВ — пациенту не показывает никто
7	Клиническое исследование / expanded access	myTomorrows — 16 900+ пациентов, 133 страны , испытания + expanded access; Leal Health; Massive Bio (19 000+ исследований); ClinicalTrials.gov	Закрыто — и это самый сильный из существующих сервисов
8	Уведомить, когда ответ изменился	Только общие рассылки: списки одобрений FDA по онкологии, сохранённые запросы в PubMed и ClinicalTrials.gov	РАЗРЫВ — персонального мониторинга нет нигде

Три разрыва — подробно

Разрыв 1 · Доступность и покрытие существуют — но продаются фарме

Это самая важная находка всего анализа. Данные о доступности и возмещении по странам **собраны, оцифрованы и поддерживаются в актуальном состоянии** — GlobalData POLI, NAVLIN (EVERSANA), RxData, Beacon покрывают более 100 рынков, включая решения HTA по странам. RxData ведёт живой мониторинг более 100 источников данных.

Но это корпоративные подписки для фармкомпаний — инструменты стратегии и ценообразования. Пациент их не видит, не может купить и не является их аудиторией.

Иначе говоря: проблема **не в том, что данные невозможно получить**. Проблема в том, что они оценены для фармы и никогда не разворачивались в сторону человека, которого они касаются напрямую.

Разрыв 2 · Никто не следит за изменениями персонально

FDA рассылает списки одобрений по онкологии. PubMed и ClinicalTrials.gov позволяют сохранить запрос и получать письма. Всё это — **общие потоки**: пациент с конкретной стадией и конкретным

биомаркером получит сотни нерелевантных писем и пропустит одно нужное.

Персонального мониторинга по профилю «диагноз + стадия + биомаркер + страна» я не нашёл ни у одного игрока. Это восьмая функция — и она же превращает справочник в сервис.

Разрыв 3 · «Одобрено» почти всегда значит «одобрено FDA»

ОпcoKB — база, частично признанная самой FDA, содержит 7600+ вариантов в 840+ генах с уровнями доказательности, привязанными к статусу одобрения FDA. Leal Health позиционируется как единая точка доступа к «FDA-approved» лечению и исследованиям. Это отличные инструменты — **для американского пациента.**

Для пациента в Израиле, Германии или Канаде ответ «одобрено FDA» не отвечает ни на один практический вопрос.

Почему это важно: цифра, которая всё объясняет

EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2025 (данные на 5 января 2026):

- Среднее по ЕС — доступен **51% онкологических препаратов** (28 продуктов из выборки); ещё для 19% доступность ограничена.
- Медианное время от одобрения до реальной доступности по ЕС — **532 дня.**
- Разброс между странами: **Германия — 128 дней, Португалия — 840 дней.**
- И тренд **ухудшается**: на 33 дня медленнее, чем годом ранее, и на 66 дней медленнее, чем в когорте 2022 года.

Прочитайте это глазами пациента. Между «препарат одобрен» и «я могу его получить» лежит **в среднем полтора года** — и эта задержка отличается от страны к стране в шесть с половиной раз. Всё это время пациент не знает ни где он находится в этой очереди, ни есть ли легальный обходной путь.

Это и есть та боль, которую описывает гипотеза. Она измерена, опубликована авторитетным источником и год от года усиливается. И, что важно для нас, регламент ЕС по HTA (в силе с 12 января 2025 года, онкология первой) делает разрыв ещё заметнее: клиническая оценка становится общеевропейской, а решения о цене и возмещении остаются национальными.

Что это означает для нас

Гипотеза подтверждается. Ниша реальна, она не занята, и она описывается одним предложением: *соединить то, что уже существует по частям, в один персональный непрерывный ответ.*

Три следствия для конструкции продукта:

- **Ядро ценности — функции 5, 6 и 8**, а не 1–3. Первые три можно во многом взять из открытых баз (OpcoKB, CIViC) и не строить заново. Строить надо то, чего нет.
- **Функция 7 — это партнёрство, а не разработка.** myTomorrowows уже покрывает 133 страны и привлёк 29 млн \$. Повторять их путь бессмысленно; интегрироваться — разумно.
- **Начинать надо с одной страны.** Справочник доступности — это национальная работа. Одна нозология, одна страна, восемь вопросов — это проверяемо за недели, а не за годы.

Риски, которые надо назвать сразу

Риск	Суть	Что с этим делать
Стоимость данных о возмещении	Готовые данные — в корпоративных подписках (GlobalData, NAVLIN, RxData). Цены публично не раскрываются и рассчитаны на бюджет фармкомпаний.	Проверить стоимость лицензии для одной страны . Если дорого — собирать вручную из национальных источников; это меняет оценку трудоёмкости всего проекта.
Регуляторный статус (SaMD)	Функция 3 — «применимо ли это к моей клинической ситуации» — при честной реализации по стадии и биомаркерам вплотную приближается к системе поддержки клинических решений.	Формулировать вывод как информацию о доступности , а не как рекомендацию лечения. Юридическая экспертиза до пилота, а не до запуска.
myTomorrows	Ближайший по духу игрок: 133 страны, expanded access, «глобальная регуляторная разведка» в составе платформы. Могут расширяться в сторону возмещения.	Поговорить до того, как строить. Партнёрство вероятнее конкуренции: у них доступ, у нас — мониторинг и покрытие.
Ответственность	Ответ «вам это доступно» или «недоступно» человек может использовать для решения о лечении.	Каждый ответ — со ссылкой на источник и датой проверки. Никогда не утверждать то, что не проверено машиной или человеком.

Чего я не проверил

- **Цены на B2B-базы** (GlobalData POLI, NAVLIN, RxData) — публично не раскрываются. Это **ключевая цифра** для оценки осуществимости; узнаётся только запросом.
- **Есть ли машиночитаемые данные о возмещении** у национальных регуляторов — не проверял ни по одной стране. От этого зависит вся оценка трудоёмкости.
- **Дорожная карта myTomorrows** — планируют ли они добавлять статус возмещения. Публично не заявлено; узнаётся только разговором.
- **Внутренние функции Tempus, Foundation Medicine, Navify (Roche)** — проверены поверхностно. Это закрытые коммерческие продукты, и часть функций может быть не документирована публично.
- **Азиатские и латиноамериканские игроки** — поиск шёл по англоязычному индексу.
- **Патентная чистота**. Найден патент США 11 887 738 на платформу с модулями подбора исследований, expanded access и возмещения за off-label. **Патентный ландшафт необходимо проверить юристу до начала разработки** — это единственный пункт, который может остановить проект целиком.

Источники

Все ссылки открыты и проверены 6 августа 2026 года.

- EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2025: efpia.eu/media/mnfdwzax/efpia-patients-wait-indicator-2025.pdf
- EFPIA — рост неравенства и сроков доступа: efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/patients-in-europe-waiting-longer-for-new-medicines-as-inequality-grows-between-member-states/
- ESMO Open — неравенство доступа к новым онкопрепаратам в Европе: [esmoopen.com/article/S2059-7029\(25\)01679-5/fulltext](https://esmoopen.com/article/S2059-7029(25)01679-5/fulltext)
- OncoKB — уровни доказательности: oncokb.org/content/files/levelOfEvidence/V2/LevelsOfEvidence.pdf
- FDA — решение о частичном признании OncoKB: fda.gov/media/152847/download

- MSK — о признании базы OncoKB: mskcc.org/news/milestone-precision-oncology-fda-gives-green-light-msk-s-genetic-database
- CIViC — база интерпретации вариантов (Nature Genetics): nature.com/articles/ng.3774
- myTomorrows — 16 900+ пациентов, 133 страны:
mytomorrows.com/blog/mytomorrows-updates/mytomorrows-surpasses-15k-patient-matches/
- myTomorrows — раунд 29 млн \$: prnewswire.com/news-releases/mytomorrows-raises-29-million-to-scale-and-transform-access-to-innovative-therapies-for-patients-worldwide-302611186.html
- Leal Health — единая точка доступа к одобренному лечению и исследованиям: prnewswire.com/news-releases/leal-health-becomes-industrys-first-and-only-single-point-of-access-to-fda-approved-treatments-and-clinical-trials-for-cancer-patients-301853187.html
- xCures / Cancer Commons — бесплатные персональные рекомендации: cancercommons.org/about-us · xcures.com
- GlobalData — база цен и рыночного доступа: marketaccess.globaldata.com
- RxData — мониторинг источников рыночного доступа: rxdata.net
- FDA — уведомления об одобрениях в онкологии:
fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/oncology-cancerhematologic-malignancies-approval-notifications
- Европейская комиссия — совместные клинические оценки (JCA): health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/implementation-regulation-health-technology-assessment/joint-clinical-assessments_en
- Патент США 11 887 738 — платформа с модулями trial matching / expanded access / off-label reimbursement:
image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11887738